BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 14 novembre 2026

2 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

PRÉVENTION **À connaître** Essai randomisé en double aveugle

Effect of discontinuing antihypertensives on perioperative hypotension in older patients before non-cardiac surgery: multicentre, randomised, double blind, controlled trial.

BMJ · 11 novembre 2026 · Essai randomisé

Cet essai multicentrique en double aveugle a comparé la prise habituelle de l'IEC ou de l'ARA2 le matin de l'intervention à un placebo chez 2 036 patients de 60 à 80 ans devant subir une chirurgie non cardiaque sous anesthésie générale. L'hypotension périopératoire est survenue chez 31,2 % des patients qui avaient reçu le placebo, contre 45,5 % de ceux qui avaient pris leur traitement, et le recours aux vasopresseurs a été moins fréquent dans le groupe placebo. Les complications et la mortalité à 30 jours, critères secondaires, n'ont pas différé significativement entre les groupes.

> **En pratique :** chez un patient de 60 à 80 ans traité par IEC ou ARA2 et devant subir une chirurgie non cardiaque sous anesthésie générale, suspendre la prise du matin de l'intervention réduit l'hypotension périopératoire et le recours aux vasopresseurs. Cet essai appuie donc la suspension de cette seule prise. Il ne permet pas de conclure sur les complications ni sur la mortalité à 30 jours, qui n'étaient que des critères secondaires.

Article original · PubMed

PRÉVENTION **Veille** Essai randomisé · BPROAD (analyse préspécifiée)

Effect of intensive blood pressure control on cognitive outcomes and brain structures in adults with type 2 diabetes: prespecified analysis of secondary outcomes of BPROAD randomised controlled trial.

BMJ · 12 novembre 2026 · Essai randomisé

Cette analyse préspécifiée de l'essai BPROAD a comparé une cible de pression artérielle systolique inférieure à 120 mm Hg et une cible inférieure à 140 mm Hg chez 12 434 diabétiques de type 2 à risque cardiovasculaire élevé, sans démence probable à l'inclusion. Après un suivi médian de 3,8 ans, le traitement intensif n'a pas réduit significativement la survenue d'une démence ou de troubles cognitifs légers (HR 0,96 ; IC95 % 0,86–1,06). Dans une sous-étude d'IRM cérébrale de taille modeste, le volume des lésions de la substance blanche a moins progressé sous traitement intensif ; ce résultat reste exploratoire.

> **En pratique :** chez le diabétique de type 2 à risque cardiovasculaire élevé, viser une pression systolique inférieure à 120 mm Hg n'a pas réduit significativement la survenue d'une démence ou de troubles cognitifs légers sur un suivi médian d'un peu moins de quatre ans. La moindre progression des lésions de la substance blanche observée en IRM est un signal exploratoire, obtenu dans un sous-groupe de taille modeste. Cette analyse ne fournit donc pas d'argument cognitif pour ou contre une cible intensive ; son choix reste à discuter sur ses effets cardiovasculaires.

Article original · PubMed

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.